

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 16 '26 AM 9:31
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1076

INFORME POSITIVO

14 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación del P. del S. 1076, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1076 tiene como propósito "...crear la "Ley de la Tarifa Supletoria de Estacionamiento en Instituciones Hospitalarias Públicas para Acompañantes de Pacientes con Hospitalización Prolongada", estableciendo una tarifa supletoria aplicable al pago de boletos de estacionamiento en instituciones hospitalarias, cuyo titular sea el Gobierno de Puerto Rico, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado, para acompañantes de pacientes con hospitalización prolongada; definir hospitalización prolongada como estancias de siete (7) días consecutivos o más; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la supervisión y regulación de su implementación; y para otros fines relacionados".

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al plantearnos que

[l]as hospitalizaciones prolongadas representan un desafío emocional y financiero significativo para las familias puertorriqueñas, donde los acompañantes — familiares o cuidadores— deben permanecer cerca de los pacientes durante períodos extendidos, enfrentando costos adicionales como el estacionamiento en las instalaciones hospitalarias. En un contexto donde el sistema de salud de la Isla

atiende a una población vulnerable, con un promedio de estadía hospitalaria en Estados Unidos de aproximadamente 5.5 días, pero con casos prolongados que superan este umbral y generan cargas acumuladas, se hace necesario aliviar estas presiones económicas para promover el acceso equitativo a la atención y el apoyo familiar durante crisis de salud.

Actualmente, muchas instituciones hospitalarias públicas en Puerto Rico cobran tarifas estándar por estacionamiento, sin mecanismos específicos para reducir costos a acompañantes de pacientes con estancias largas, lo que puede desincentivar visitas esenciales y agravar el estrés de las familias. Esta Ley propone una tarifa supletoria —una tasa reducida o descontada aplicable mediante validación— para estos casos, definiendo hospitalización prolongada como estancias de siete (7) días consecutivos o más. Esta definición se basa en prácticas comunes en jurisdicciones estadounidenses, donde estancias prolongadas se consideran a partir de siete (7) a catorce (14) días para políticas de apoyo, reconociendo que superan el promedio y requieren intervenciones especiales para mitigar impactos financieros.

En el ámbito comparado, varios estados de Estados Unidos han implementado políticas similares para aliviar el costo del estacionamiento en hospitales. Por ejemplo, en Maryland, la legislación HB519 (2025) requiere que los hospitales ofrezcan estacionamiento gratuito para pacientes hospitalizados durante toda la duración de su admisión, extendiendo beneficios a acompañantes en casos de larga duración. En otros estados como Illinois y Iowa, hospitales han reducido tarifas diarias máximas a \$10 tras quejas de pacientes, ofreciendo pases de 10 días por \$25 para visitantes frecuentes en tratamientos prolongados.

Además, centros oncológicos en Estados Unidos proporcionan descuentos semanales o mensuales, validaciones y estacionamiento gratuito para pacientes en terapias extendidas, reconociendo que estancias de catorce (14) a veintiún (21) días o más representan el catorce por ciento (14%) de los días hospitalarios totales y generan costos significativos. Estos modelos, adaptados al contexto puertorriqueño, inspiran al establecimiento de una tarifa supletoria que reduzca barreras, promoviendo la equidad y el bienestar familiar sin alterar drásticamente las operaciones hospitalarias pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado.

Dado que, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) es la agencia con autoridad para regular tarifas máximas, prácticas de cobro y operaciones de áreas de estacionamiento público en Puerto Rico conforme al Reglamento de Áreas de Estacionamiento Público (Reglamento 6753) y sus funciones de fiscalización de tarifas abusivas o irregulares—, resulta apropiado asignarle la supervisión de esta Ley. El DACO ya regula tarifas en estacionamientos públicos, incluyendo periodos de gracia en accesos a emergencias hospitalarias y ha intervenido en casos de cobros excesivos en diversas zonas, lo que lo posiciona como la entidad idónea

para garantizar el cumplimiento uniforme, la estandarización del proceso de validación y la protección al consumidor en este ámbito específico.

Esta legislación le ordena a las instituciones hospitalarias pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, que ostenten la titularidad de un estacionamiento para uso público, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado la implementación de una tarifa supletoria en el pago del boleto de dicho estacionamiento, para que los acompañantes de un paciente con una estadía prolongada, puedan solicitarla mediante un proceso simple de validación, como presentación de documentación hospitalaria. De esta forma, se fomenta el apoyo a familias durante hospitalizaciones prolongadas, alineándose con recomendaciones de políticas de salud que priorizan la accesibilidad y la reducción de costos indirectos en atención médica.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para la debida evaluación del proyecto de marras, la Comisión recibió los memoriales explicativos de los departamentos de Asuntos del Consumidor; y de Salud, de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN), la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Debemos comenzar la discusión de esta medida, destacando que, en un principio, esta persiguió establecer una tarifa supletoria aplicable al pago de boletos de estacionamiento en instituciones hospitalarias, sin importar el carácter público o privado de estas. Sin embargo, tras analizar los comentarios vertidos por la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, en la ponencia que nos remitieran, la Comisión de de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor entendió prudente y razonable hacerla extensiva a instituciones hospitalarias pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, que ostenten la titularidad de un estacionamiento para uso público, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado.

En su escrito, dijeron desde la Asociación de Hospitales de Puerto Rico que "(...) La hospitalización prolongada de un familiar o ser querido puede implicar gastos indirectos significativos para los acompañantes, incluyendo transportación, alimentos, ausencias laborales y estacionamiento. Sin embargo, aun partiendo de esa preocupación válida, el mecanismo propuesto por el proyecto traslada al hospital una carga económica, administrativa y regulatoria adicional, sin distinguir entre instituciones, modelos operacionales, contratos vigentes, titularidad de los estacionamientos, condición financiera, ubicación geográfica, capacidad física, ni si el estacionamiento es operado directamente por el hospital o por un tercero". (Énfasis nuestro).

Añadieron que

...el proyecto convierte una política de apoyo familiar en una obligación tarifaria uniforme sobre todos los hospitales. Ese enfoque resulta problemático porque los hospitales no operan bajo una misma estructura física, contractual ni financiera. Algunos hospitales poseen estacionamientos propios; otros utilizan estacionamientos arrendados; otros dependen de operadores externos; otros se encuentran en zonas urbanas con limitaciones severas de espacio; y otros cuentan con estacionamientos limitados destinados a pacientes, empleados, médicos, suplidores, ambulancias, servicios de emergencia y visitantes.

El proyecto no distingue entre esas realidades. Tampoco contempla que muchos estacionamientos hospitalarios operan bajo contratos privados con terceros, con estructuras de canon, mantenimiento, seguros, seguridad, repago de inversión, control de acceso, sistemas de boletaje y obligaciones contractuales ya pactadas. La imposición legislativa de una tarifa reducida, sin análisis de impacto, podría alterar esos contratos y generar costos que finalmente recaerían sobre el hospital. (Énfasis nuestro).

Comunicaron, además, que

...imponer por ley una reducción tarifaria obligatoria, acompañada de informes, validaciones, fiscalización y posibles sanciones, equivale a crear un mandato no financiado sobre instituciones que ya enfrentan presiones financieras y operacionales significativas. Aunque el P. del S. 1076 se presenta como una medida dirigida a reducir el costo de estacionamiento para acompañantes de pacientes con hospitalización prolongada, su efecto práctico puede incluir pérdida de ingresos, renegociaciones contractuales con operadores de estacionamiento, costos administrativos adicionales, ajustes tecnológicos, horas de personal, auditorías internas, atención de reclamaciones, producción de informes anuales y exposición regulatoria adicional.

Esa carga no puede evaluarse aisladamente ni como un asunto menor, particularmente cuando el propio análisis de la industria hospitalaria en Puerto Rico advierte sobre riesgos de cierre, consolidación y deterioro del acceso si no se atienden adecuadamente las presiones económicas del sector. Por ello, antes de imponer cualquier obligación tarifaria adicional sobre los hospitales, la Asamblea Legislativa debe reconocer que el sector hospitalario de Puerto Rico atraviesa una etapa de fragilidad financiera documentada, en la cual incluso cargas administrativas aparentemente limitadas pueden acumularse y afectar la estabilidad operacional de instituciones esenciales para la salud pública del País.

(Énfasis nuestro)

En conclusión, la Asociación, aunque reconoció la "intención humanitaria" que inspira el proyecto, entienden que *"...una política pública bien intencionada no debe adoptarse mediante un mecanismo que imponga nuevas cargas económicas, administrativas, contractuales y regulatorias sobre instituciones hospitalarias sin un estudio previo de impacto y sin una fuente*

de financiamiento". También, les parece que, según redactado, el proyecto "...establece un mandato uniforme y no financiado sobre todos los hospitales de Puerto Rico, sin distinguir entre instituciones que operan directamente sus estacionamientos y aquellas cuyos estacionamientos son arrendados, concesionados, administrados por terceros o sujetos a contratos privados vigentes. Tampoco toma en consideración la capacidad física de cada instalación, la disponibilidad real de espacios, la ubicación geográfica, los costos de operación, la situación financiera de los hospitales ni los efectos que la medida podría tener sobre la seguridad, el flujo vehicular y el acceso a servicios esenciales".

Por todo lo anterior, solicitaron que el P. del S. 1076 no fuese aprobado.

Ahora bien, en contraposición a lo esbozado por la Asociación de Hospitales, tanto el Departamento de Salud, así como la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), si dijeron favorecer el proyecto.

En el caso del Departamento de Salud, argumentaron que

...en el Hospital Universitario Dr. Ramon Ruiz Arnau (HURRA), adscrito a este Departamento, el cobro por estacionamiento a visitantes fue eliminado hace aproximadamente dos años. Actualmente, el servicio es gratuito para todos los usuarios sin distinción, incluyendo pacientes hospitalizados y beneficiarios de programas como Inmunología, Centro Pediátrico, Madres, Niños y Adolescentes, Avanzando Juntos, Envejecimiento Saludable, Epidemiología y Vacunación. De igual modo, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) administrados por el Departamento o bajo acuerdos de administración en Vieques, Adjuntas, Culebra, Loiza, Rio Grande, Lajas, Maricao, Dorado y Vega Alta no imponen cargos por concepto de estacionamiento. Aunque el proyecto se concentra en pacientes hospitalizados, esta información es pertinente para resaltar que la no imposición de cargos es una práctica ya establecida en las instalaciones bajo nuestra supervisión.

Por otro lado, se informa que el Hospital Pediátrico Universitario (HOPU) y el Hospital Universitario de Adultos (UDH), también adscritos a este Departamento, no poseen estacionamientos propios para pacientes o visitantes. En la actualidad, el hospital arrienda espacios a la empresa Medical Center Parking exclusivamente para personal empleado. Los estacionamientos disponibles en el Centro Médico son operados por dicha compañía hasta el año 2028, fecha en que la Administración de Servicios Médicos (ASEM) asumirá su administración. Debido a esta situación operacional, las disposiciones del P. del S. 1076 no resultarían de aplicación inmediata a estos hospitales, dado que el Departamento no controla ni administra dichas áreas de estacionamiento.

Más adelante, dijeron que *"...al evaluar la medida íntegramente, coincidimos en que persigue un fin loable y presenta características favorables para la política pública y la protección ciudadana. La legislación atiende una necesidad documentada al ofrecer un alivio económico*

directo a los acompañantes de pacientes en situaciones de vulnerabilidad, mitigando una carga financiera recurrente. La adopción de este sistema de tarifas reducidas, basado en modelos exitosos de otras jurisdicciones, añade legitimidad y viabilidad operativa a la propuesta, posicionándola como una política moderna y fundamentada en evidencia”.

Asimismo, sostuvieron que “...el P. del S. 1076 constituye una propuesta bien organizada que tiene como objetivo reducir la carga económica de las familias puertorriqueñas en tiempos difíciles, creando un marco regulatorio definido y mecanismos de supervisión apropiados. Creemos que esta iniciativa ayudarla a asegurar una mayor equidad y transparencia para aquellos que asisten a pacientes durante estancias hospitalarias prolongadas”. En atención a esto último, el “...Departamento de Salud endosa el Proyecto del Senado 1076”. (Énfasis nuestro).

Por su parte, la ASEM también se expresó entusiastamente a favor de la medida objeto de este informe. En su memorial explicativo, esgrimieron endosar “...de manera incondicional el Proyecto del Senado 1076...”. Entienden que el proyecto atiende, de manera directa y razonable, una necesidad concreta de los pacientes y sus familias. La medida se caracteriza por lo siguiente:

Primero, establece una definición objetiva y clínicamente razonable de hospitalización prolongada —siete (7) días consecutivos o más —, umbral que supera el promedio de estadía hospitalaria y que, por tanto, identifica apropiadamente los casos que generan cargas acumuladas significativas para los acompañantes.

Segundo, no impone una tarifa única y rígida, sino que fija un tope máximo equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa estándar diaria, permitiendo flexibilidad operacional sin perder el beneficio para el paciente y su familia.

Tercero, contempla un mecanismo sencillo de validación mediante documentación emitida por la propia institución hospitalaria, así como la emisión de pases diarios, semanales o mensuales conforme a la duración estimada de la estancia. Esto atiende adecuadamente la variabilidad de los casos clínicos.

Cuarto, asigna la supervisión y reglamentación al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), agencia que ya posee la pericia, el marco normativo y la experiencia fiscalizadora en materia de áreas de estacionamiento público, conforme al Reglamento Núm. 6753 y legislación afín.

Quinto, incorpora una obligación de transparencia mediante rotulación visible, campañas educativas a informes anuales, elementos que garantizan que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan y que permiten evaluar periódicamente la implementación de la política pública.

Enfatizaron en que "...estos elementos, en conjunto, configuran una medida razonable, proporcional y enfocada en el bienestar del paciente y de sus familiares, en línea con las mejores prácticas adoptadas en otras jurisdicciones estadounidenses que la propia exposición de motivos cita".

Finalizan estableciendo que "[p]or todas las consideraciones antes expuestas, la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico endosa de manera incondicional el Proyecto del Senado 1076. Entendemos que la medida representa un paso concreto, razonable y humanitario en favor de los pacientes hospitalizados por periodos prolongados y de sus acompañantes, quienes enfrentan, junto al paciente, el peso emocional, físico y económico de la enfermedad". (Énfasis nuestro).

HB2 No obstante, sugirieron que se considere la inclusión de lenguaje que obligue a incorporar la tarifa supletoria como cláusula mandatoria en todo contrato futuro de arrendamiento, concesión o administración de facilidades de estacionamiento hospitalario, de manera que la política pública quede protegida en el tiempo. Esto, porque la mayoría de las instituciones hospitalarias en Puerto Rico, incluyendo las que forman parte del Centro Médico, sus facilidades de estacionamiento se encuentran subarrendadas, concesionadas u operadas por compañías privadas especializadas bajo contratos de administración. Tales contratos establecen las estructuras tarifarias, los periodos de vigencia y las condiciones de operación, y fueron suscritos con anterioridad a la presentación del P. del S. 1076. Igualmente, entienden conveniente proveerle al DACO, en el proceso reglamentario de noventa (90) días, flexibilidad para establecer mecanismos transitorios de cumplimiento en aquellos casos en que existan contratos de concesión vigentes. En consideración a esto, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico ha incorporado en el texto del proyecto, una cláusula que aclara que

[t]oda institución hospitalaria pública que, por sí misma, opere un local, solar o área que se utilice por cualquier persona para permitir que en el mismo se estacionen vehículos de motor mediante el pago de alguna cantidad de dinero, tendrá noventa (90) días, contados a partir de la aprobación de esta Ley, para establecer la tarifa supletoria a la que aquí se hace referencia. En el caso de aquellas instituciones hospitalarias públicas que tengan contratada la operación del estacionamiento con un arrendatario o poseedor privado, incluirán las cláusulas correspondientes, acorde con esta Ley, según renueven dichos contratos.

Con la antes descrita enmienda, atendemos las preocupaciones de la ASEM, en cuanto a la adecuada implantación de la medida.

Para terminar, el DACO manifestó que el P. del S. 1076 persigue un fin loable y avalaron su aprobación. En cuanto al OMBUDSMAN, favorecen el proyecto. Acotaron que "[l]a realidad económica que enfrentan numerosos ciudadanos en Puerto Rico incide

directamente en su capacidad para acompañar a sus seres queridos durante una hospitalización. En muchas ocasiones, aun cuando existe el deseo de permanecer junto al paciente o visitarlo con frecuencia, los costos asociados al estacionamiento, la alimentación y otros gastos representan una carga económica que algunas familias no pueden asumir (...)".

Comentaron, también, que "[c]omo consecuencia de esa realidad, son muchos los pacientes que permanecen solos y que no reciben visitas ni el acompañamiento de sus familiares por razones estrictamente económicas. Esta situación resulta particularmente difícil, pues el apoyo emocional y la compañía de los seres queridos constituyen elementos importantes durante el proceso de recuperación y tratamientos médicos".

Así las cosas, se pronunciaron a favor de la aprobación del Proyecto del Senado 1076, aunque entienden se deben incluir enmiendas dirigidas a precisar el alcance de las facultades del DACO, fortalecer los mecanismos de cumplimiento y fiscalización, así como a que se consideren mecanismos adicionales que permitan ampliar el alcance de la medida.

Hon Evaluado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, la medida propone establecer un marco normativo específico en Puerto Rico, dirigido a establecer una tarifa supletoria aplicable al pago de boletos de estacionamiento en instituciones hospitalarias, cuyo titular sea el Gobierno de Puerto Rico, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado, para acompañantes de pacientes con hospitalización prolongada; definir hospitalización prolongada como estancias de siete (7) días consecutivos o más. Específicamente, esta Ley sería aplicable, únicamente, a cualquier hospital, centro de salud, unidad de salud pública o centro de diagnóstico o tratamiento perteneciente al Gobierno Estatal de Puerto Rico o a alguna de sus corporaciones o instrumentalidades públicas, que ostente la titularidad de un estacionamiento para uso público, ya sea este operado por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado. Se excluye, expresamente, a cualquier hospital, centro de salud o centro de diagnóstico o tratamiento privado o municipal, según lo planteado por la Asociación de Hospitales.

Debemos poner en contexto que esta pieza legislativa no nace de un vacío, sino que parte de comparaciones con políticas adoptadas en estados como Maryland, Illinois a Iowa, donde se han reducido tarifas o establecidos estacionamientos gratuitos para pacientes y acompañantes en hospitalizaciones prolongadas. Asimismo, ya hay centros oncológicos en Estados Unidos que ya implementan descuentos semanales o mensuales, validaciones especiales y gratuidad parcial del estacionamiento para casos clínicos que requieren hospitalizaciones de catorce a veintiún días. El proyecto toma estos modelos como punto de referencia para proponer una versión adaptada a nuestra localidad.

En cuanto a su diseño operativo, la medida establece que la tarifa supletoria no podrá exceder el cincuenta por ciento de la tarifa estándar diaria. Esta estructura permite crear un balance entre la protección del consumidor y la sostenibilidad para las instituciones hospitalarias. El proceso de validación se define como uno sencillo, basado en la certificación de la hospitalización prolongada y la relación del acompañante con el paciente. También, contempla pases diarios, semanales o mensuales, lo que flexibiliza la aplicación de la tarifa reducida según la duración de la hospitalización. Este componente administrativo demuestra una intención de facilitar el uso del beneficio y evitar procesos burocráticos que puedan disuadir su utilización.

De igual manera, el proyecto asigna al Departamento de Asuntos del Consumidor la supervisión y regulación del cumplimiento. Esta decisión es coherente con las facultades de la agencia, que ya regula áreas de estacionamiento público bajo el Reglamento 6753. La intervención del DACO busca garantizar uniformidad, evitar tarifas abusivas y promover transparencia en la implementación del beneficio. Este enfoque preventivo y estructurado fortalece la capacidad de fiscalización. Entendemos nada impide su aprobación.

Para finalizar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

Expuesto ello, y a base de los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1076 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobación del Proyecto del Senado 1076, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Héctor Joaquín Sánchez Álvarez
Presidente

Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1076

10 de febrero de 2026

Presentado por la señora Soto Aguilú

Referido a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

LEY

Para crear la "Ley de la Tarifa Supletoria de Estacionamiento en Instituciones Hospitalarias Públicas para Acompañantes de Pacientes con Hospitalización Prolongada", estableciendo ~~establecer~~ una tarifa supletoria aplicable al pago de boletos de estacionamiento en instituciones hospitalarias, cuyo titular sea el Gobierno de Puerto Rico, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado, para acompañantes de pacientes con hospitalización prolongada; definir hospitalización prolongada como estancias de siete (7) días consecutivos o más; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la supervisión y regulación de su implementación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las hospitalizaciones prolongadas representan un desafío emocional y financiero significativo para las familias puertorriqueñas, donde los acompañantes —familiares o cuidadores— deben permanecer cerca de los pacientes durante períodos extendidos, enfrentando costos adicionales como el estacionamiento en las instalaciones hospitalarias. En un contexto donde el sistema de salud de la Isla atiende a una población vulnerable, con un promedio de estadía hospitalaria en Estados Unidos de aproximadamente 5.5 días, pero con casos prolongados que superan este umbral y

generan cargas acumuladas, se hace necesario aliviar estas presiones económicas para promover el acceso equitativo a la atención y el apoyo familiar durante crisis de salud.

Actualmente, muchas instituciones hospitalarias públicas en Puerto Rico cobran tarifas estándar por estacionamiento, sin mecanismos específicos para reducir costos a acompañantes de pacientes con estancias largas, lo que puede desincentivar visitas esenciales y agravar el estrés de las familias. Esta ~~medida~~ Ley propone una tarifa supletoria —una tasa reducida o descontada aplicable mediante validación— para estos casos, definiendo hospitalización prolongada como estancias de siete (7) días consecutivos o más. Esta definición se basa en prácticas comunes en jurisdicciones estadounidenses, donde estancias prolongadas se consideran a partir de ~~7 a 14~~ siete (7) a catorce (14) días para políticas de apoyo, reconociendo que superan el promedio y requieren intervenciones especiales para mitigar impactos financieros.

En el ámbito comparado, varios estados de Estados Unidos han implementado políticas similares para aliviar el costo del estacionamiento en hospitales. Por ejemplo, en Maryland, la legislación HB519 (2025) requiere que los hospitales ofrezcan estacionamiento gratuito para pacientes hospitalizados durante toda la duración de su admisión, extendiendo beneficios a acompañantes en casos de larga duración. En otros estados como Illinois y Iowa, hospitales han reducido tarifas diarias máximas a \$10 tras quejas de pacientes, ofreciendo pases de 10 días por \$25 para visitantes frecuentes en tratamientos prolongados.

Además, centros oncológicos en Estados Unidos proporcionan descuentos semanales o mensuales, validaciones y estacionamiento gratuito para pacientes en terapias extendidas, reconociendo que estancias de ~~14 a 21~~ catorce (14) a veintiún (21) días o más representan el catorce por ciento (14%) de los días hospitalarios totales y generan costos significativos. Estos modelos, adaptados al contexto puertorriqueño, inspiran al establecimiento de una tarifa supletoria que reduzca barreras, promoviendo la equidad y el bienestar familiar sin alterar drásticamente las operaciones hospitalarias pertenecientes

al Gobierno de Puerto Rico, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado.

Dado que, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) es la agencia con autoridad para regular tarifas máximas, prácticas de cobro y operaciones de áreas de estacionamiento público en Puerto Rico conforme al Reglamento de Áreas de Estacionamiento Público (Reglamento 6753) y sus funciones de fiscalización de tarifas abusivas o irregulares—, resulta apropiado asignarle la supervisión de esta ~~medida~~ Ley. El DACO ya regula tarifas en estacionamientos públicos, incluyendo periodos de gracia en accesos a emergencias hospitalarias y ha intervenido en casos de cobros excesivos en diversas zonas, lo que lo posiciona como la entidad idónea para garantizar el cumplimiento uniforme, la estandarización del proceso de validación y la protección al consumidor en este ámbito específico.

Esta legislación le ordena a las instituciones hospitalarias pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico, que ostenten la titularidad de un estacionamiento para uso público, ya sean estos operados por la propia entidad gubernamental o a través de un arrendatario o poseedor privado la implementación de esta una tarifa supletoria en el pago del boleto de dicho estacionamiento, ~~bajo la supervisión y regulación del DACO~~, para que los acompañantes de un paciente con una estadía prolongada, puedan solicitarla mediante un proceso simple de validación, como presentación de documentación hospitalaria. De esta forma, se fomenta el apoyo a familias durante hospitalizaciones prolongadas, alineándose con recomendaciones de políticas de salud que priorizan la accesibilidad y la reducción de costos indirectos en atención médica.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1

Artículo 1.- Título.

1 Esta Ley se conocerá como la "Ley para la Tarifa Supletoria de Estacionamiento en
2 Instituciones Hospitalarias Públicas para Acompañantes de Pacientes con Hospitalización
3 Prolongada".

4 Artículo 2.- Aplicabilidad de la Ley

5 Esta Ley será aplicable, únicamente, a cualquier hospital, centro de salud, unidad de salud
6 pública o centro de diagnóstico o tratamiento perteneciente al Gobierno Estatal de Puerto Rico o a
7 alguna de sus corporaciones o instrumentalidades públicas, que ostente la titularidad de un
8 estacionamiento para uso público, ya sea este operado por la propia entidad gubernamental o a
9 través de un arrendatario o poseedor privado. Se excluye, expresamente, a cualquier hospital,
10 centro de salud o centro de diagnóstico o tratamiento privado o municipal.

11 Toda institución hospitalaria pública que, por sí misma, opere un local, solar o área que se
12 utilice por cualquier persona para permitir que en el mismo se estacionen vehículos de motor
13 mediante el pago de alguna cantidad de dinero, tendrá noventa (90) días, contados a partir de la
14 aprobación de esta Ley, para establecer la tarifa supletoria a la que aquí se hace referencia. En el
15 caso de aquellas instituciones hospitalarias públicas que tengan contratada la operación del
16 estacionamiento con un arrendatario o poseedor privado, incluirán las cláusulas correspondientes,
17 acorde con esta Ley, según renueven dichos contratos.

18 Artículo 2 3.- Definiciones.

19 Para los propósitos de esta Ley:

20 a) "Hospitalización prolongada" significa una estancia hospitalaria continua de
21 siete (7) días o más en una institución hospitalaria pública.

1 b) "Acompañante" significa familiares directos, cuidadores designados o personas
2 autorizadas por el paciente para brindar apoyo durante la hospitalización.

3 c) "Tarifa supletoria" significa una tasa reducida o descontada, no superior al 50%
4 de la tarifa estándar diaria, aplicable al pago de boletos de estacionamiento en las
5 facilidades de la institución hospitalaria pública.

6 d) "Institución hospitalaria pública" significa cualquier hospital público ~~o privado~~
7 en Puerto Rico que ofrezca servicios de hospitalización y cuente con facilidades de
8 estacionamiento controladas.

9 e) "DACO" significa el Departamento de Asuntos del Consumidor.

10 Artículo 3 4.- Implementación de la Tarifa Supletoria.

11 Todas las instituciones hospitalarias públicas en Puerto Rico deberán ofrecer una
12 tarifa supletoria para el pago de boletos de estacionamiento a acompañantes de pacientes
13 con hospitalización prolongada. Esta tarifa se aplicará mediante un proceso de validación
14 sencillo que se le proveerá al operador del estacionamiento, que incluirá:

15 a) Presentación de documentación emitida por la propia institución hospitalaria
16 pública que certifique la hospitalización prolongada del paciente y la relación del
17 acompañante.

18 b) Emisión de pases diarios, semanales o mensuales con la tarifa reducida, según
19 la duración estimada de la estancia.

20 c) Exención de cargos adicionales por pérdida de boletos o extensiones razonables,
21 siempre que se mantenga la validación activa.

1 El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) supervisará el
2 cumplimiento de esta disposición, emitiendo regulaciones dentro de los 90 días
3 siguientes a la vigencia de esta Ley para estandarizar el proceso de validación, las tarifas
4 máximas permitidas bajo la tarifa supletoria y los mecanismos de fiscalización.

5 Artículo 4 5.- Colaboración y Promoción de la Ley.

6 Las instituciones hospitalarias públicas instalarán ~~colaborarán con el DACO para~~
7 ~~informar a pacientes y acompañantes sobre esta tarifa supletoria mediante~~ carteles
8 visibles en áreas de admisión, estacionamiento y sitios web institucionales, dirigidos a
9 informarle a los pacientes y sus acompañantes sobre las disposiciones de esta Ley. El DACO
10 promoverá campañas educativas para ~~maximizar su utilización y garantizar el~~
11 conocimiento y cumplimiento de esta Ley, a través de sus redes sociales y su portal cibernético.

12 Artículo 5 6.- Informes.

13 Cada institución hospitalaria pública presentará informes anuales al DACO sobre
14 la implementación de esta tarifa, incluyendo el número de validaciones emitidas, montos
15 recaudados bajo la tarifa supletoria y recomendaciones para mejoras. El DACO
16 consolidará estos datos en ~~un~~ el informe anual que le somete a la Asamblea Legislativa y al
17 Gobernador de Puerto Rico, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de la Ley Núm. 5
18 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de
19 Asuntos del Consumidor".

20 Artículo 6 7.- Cláusula de Separabilidad.

1 Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado
2 por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no
3 afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

4 Artículo 7 g.- Vigencia.

5 Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación.

402